

GLAUCOMA AGUDO DE ÁNGULO CERRADO

Álvaro Rodríguez Castelblanco, Marta Cuesta Lasso, Carlos Plaza Laguardia.

INTRODUCCIÓN

El ataque agudo de glaucoma o glaucoma agudo por cierre angular (GAAC) es un aumento brusco de la presión intraocular debido a un bloqueo de la malla trabecular (sitio de drenaje del humor acuoso) por el iris periférico, debido a dos posibles mecanismos:

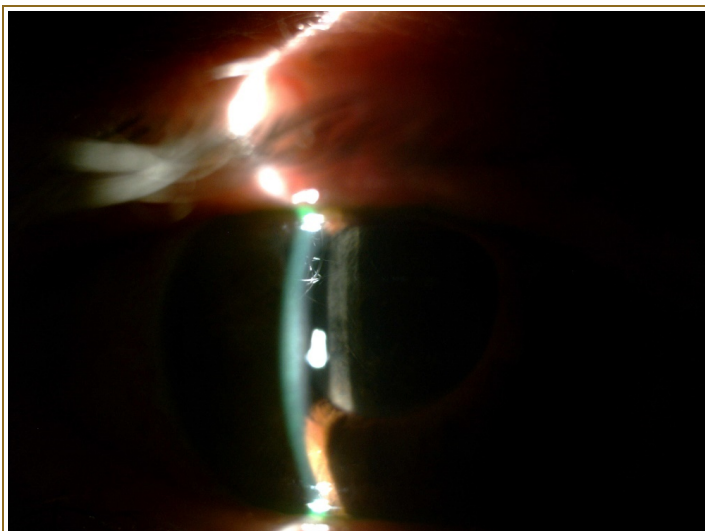
- **Bloqueo Pupilar:** aposición excesiva entre el cristalino y el iris que causa un bloqueo del flujo de humor acuoso desde la cámara posterior a la anterior, generando un aumento de la presión en la cámara posterior que provoca un bloqueo pupilar relativo y abombamiento anterior iridiano. De esta forma el iris ocluye la malla trabecular, no pudiendo ser drenado el humor acuoso, causando un aumento de la presión intraocular (PIO). Este mecanismo no ocurre en todos los ojos, existe cierta predisposición en aquellos ojos cortos (hipermétropes), con cristalino (fáquicos) grueso, o de longitud axial normal, pero con cámara anterior estrecha.
- **Configuración anómala del Iris:** Se conoce como iris en meseta, y consta a grandes rasgos en un “exceso” de iris que queda plano en la zona central y plegado en la zona periférica, pudiendo causar el bloqueo de la malla trabecular sin un bloqueo pupilar desencadenante.

Existen ciertos factores de riesgo para el cierre angular que deben ser recabados en la anamnesis: hipermetropía, antecedentes familiares de glaucoma, edad avanzada, sexo femenino y origen asiático.

DIAGNÓSTICO

La historia habitual es un paciente de sexo femenino de unos 50 años de edad que acude por intenso dolor en uno de sus ojos e incluso cefalea frontal, ojo rojo, disminución súbita de visión descrito como “visión borrosa” asociado o no a percepción de halos pudiendo presentar además náuseas y vómitos. En muchos casos se puede recabar un mecanismo desencadenante como el uso de midriáticos tópicos (fenilefrina, ciclopléjico o tropicamida), anticolinérgicos sistémicos (antidepresivos o antihistamínicos) o topiramato, así como acomodación (por ejemplo, al leer), estrés o condiciones de baja luminosidad (midriasis).

Al examen físico se podrá percibir un aumento de tensión por digitopresión (el globo ocular se siente firme a la palpación en comparación con el ojo no afecto), inyección conjuntival mixta, córnea poco transparente por edema (causante de la visión borrosa), cámara anterior estrecha (poco espacio entre el primer y segundo haz de luz al explorar con el haz de la lámpara de hendidura a 45°) y pupila en midriasis media, siendo importante valorar los reflejos pupilares dada su falta de reactividad.



Paciente intervenida de cirugía de cataratas con GAAC. Al examen físico se aprecia una cámara anterior estrecha por espacio mínimo entre los 2 haces de luz cuando ésta se proyecta a 45° desde la lámpara de hendidura.



Paciente con GAAC donde puede apreciarse el mecanismo de bloqueo pupilar por un cristalino intumesciente. Nótese la presencia de cámara estrecha, la convexidad del iris, la escasa respuesta miótica de la pupila a pesar de enfrentarse a la luz y el enrojecimiento conjuntival.

TRATAMIENTO

Este cuadro constituye una emergencia oftalmológica. De no ser tratado de forma inmediata puede llevar a la ceguera en 24-48 horas por afectación de la circulación de la cabeza del nervio óptico o provocar severas secuelas visuales.

Se debe disminuir rápidamente la presión intraocular utilizando colirios hipotensores como brimonidina (Alphagan®) o timolol (Timofтол®), hipotensores oculares sistémicos como acetazolamida oral (Edemox®) y en algunos casos diuréticos osmóticos como manitol al 20% intravenoso. Es importante frenar el mecanismo de bloqueo pupilar con colirio de pilocarpina al 2% para prevenir una recurrencia inmediata.

El manejo definitivo (iridotomía periférica con láser YAG) debe ser realizado por el oftalmólogo. Es importante la pronta derivación o contacto con el oftalmólogo de guardia de un centro especializado una vez iniciado el manejo en urgencias.

NO OLVIDAR

- Paciente con digitopresión ocular elevada, ojo rojo, visión borrosa y/o de halos, cámara estrecha y mucho dolor que no cede de forma esperada con colirio de anestésico: GAAC hasta que se demuestre lo contrario.

- Manejo inicial:
 - 1 gota de Alphagan® y/o Timofтол® u otro colirio hipotensor. Repetir 3 tandas separadas por 15 minutos hasta valoración por especialista.
 - Edemox 1-2 comprimidos por vía oral (comprobar ausencia de alergias o insuficiencia renal)
 - Pilocarpina 2% 1 gota cada 10–15 minutos 4 veces o hasta valoración por especialista.
 - Derivación a oftalmología de forma urgente.
 - ¡¡¡PROHIBIDO USO DE MIDRIÁTICOS!!!

BIBLIOGRAFÍA

- Galvis V, Tello A, Díaz C. Revista MedUNAB, Vol. 11, Número 3, Cap. 7: Diagnóstico del ojo rojo para el médico de atención primaria (p. 237). Bucaramanga, Colombia: Editorial MedUNAB, 2008.
- Montenegro M. Guías para manejo de urgencias. Cap. XVI: Glaucoma agudo de ángulo cerrado (p. 1011- 1014). Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, 2009.
- Gerstenblith A, Rabinowitz M. Manual de oftalmología del Wills Eye Institute. 6ta Edición. Cap. 9: Glaucoma (p. 213). Philadelphia, Estados Unidos: Editorial Wolters Kluwer, 2012.